

MODELO BIOTECH

VERSIÓN 3.1

rNPV · Checklist ponderado · Gestión de posición · Partnerships · KOL sentiment

Versión	3.1 — Junio 2026
Escala scoring	0 – 20 puntos · 14 criterios originales + 8 ampliaciones + 6 gaps corregidos
Veredictos	COMPRAR ≥ 16 · VIGILAR 12–15 · DESCARTAR < 12
Novedades v3.1 — Falsos negativos corregidos	
Gap 1	Asimetría de valoración (precio vs floor de caja)
Gap 2	Valor de plataforma tecnológica (shots on goal independientes)
Gap 3	Timing de entrada en ciclo sectorial (modificador sizing)
Gap 4	Riesgo regulatorio internacional (EMA, HTA, G-BA, NICE)
Gap 5	Ejecución comercial post-aprobación (adopción, payers, equipo)
Gap 6	Balance completo (convertibles, warrants, litigios, off-balance)
Gap 7	Riesgo management turnover (C-suite últimos 6 meses)
Gap 8	Concentración ownership institucional (calidad base accionarial)
Fuentes válidas	FDA · EMA · ClinicalTrials.gov · SEC/EDGAR · IR oficial · Peer-reviewed

◆ PARTE 0 — REGLAS DE ORO Y CLASIFICACIÓN PREVIA

Reglas de oro — NO negociables:

- Solo fuentes verificables. Nada de Twitter, foros ni rumores.
- Si faltan datos relevantes → indicarlo explícitamente, no inventar.
- Cada afirmación: DATO (fuente) → INTERPRETACIÓN → CONCLUSIÓN.
- Indicar siempre la fecha del último 10-Q / 20-F consultado.
- Nunca confundir catalizador de precio con catalizador clínico.

TIPO	DESCRIPCIÓN	IMPLICACIÓN CLAVE
A · Single Asset	Todo depende de un fármaco	Sizing pequeño. Catalizador binario.
B · Multi-Asset	Pipeline diversificado	Valorar por suma de partes (rNPV).
C · Platform Tech	Tecnología genera múltiples activos	Valor plataforma + pipeline. Aplicar Parte 2.8.
D · Commercial	Ya vende productos	Revenue, gross margin, market share. Aplicar Parte 7.3.

◆ PARTE 1 — RESUMEN EJECUTIVO (MÁX. 150 PALABRAS)

- ¿Qué desarrolla y para qué indicación?
- ¿Fase actual del activo principal?
- ¿Cuál es el catalizador más próximo y cuándo?
- ¿Cuál es el riesgo más letal para la tesis?
- ¿Hay partnerships activos que cambien el perfil de riesgo?
- ¿Hay riesgo de ejecución comercial o regulatorio internacional relevante?
- Encaje preliminar en cartera: SÍ / VIGILAR / NO

◆ PARTE 2 — ANÁLISIS CLÍNICO Y REGULATORIO /14

2.1 Mecanismo de acción /2

- ¿Validado en humanos o solo preclínico? → diferencia enorme.
- ¿First-in-class (más riesgo/más premio) o best-in-class (más competencia/más datos)?

2.2 Necesidad médica no cubierta /2

- Gap terapéutico real: ¿hay opciones aceptables ya aprobadas?
- Tamaño del problema: prevalencia, mortalidad, calidad de vida.

2.3 Calidad de los datos clínicos /3 ■ CRÍTICO

- Tamaño muestral, duración del seguimiento, endpoints.
 - P-value está bien, pero lo que importa es el EFFECT SIZE (HR, ORR, mPFS).
 - ¿Hubo cambios de endpoint durante el ensayo? → RED FLAG grave.
 - ¿Datos publicados en revista peer-reviewed o solo nota de prensa?
 - NNT (Number Needed to Treat) vs comparador activo.
- Análisis estadístico con intervalos de confianza completos, no solo $p < 0.05$.

2.4 Perfil de seguridad /2

- AEs grado 3-4, discontinuaciones, muertes relacionadas.

- Comparativa directa vs estándar actual.
- ¿Necesitará REMS? (complica la comercialización).

2.5 Diseño del ensayo y endpoint vs historial FDA /2 ■ AMPLIADO v3.1

Diseño del ensayo:

- ¿Randomizado, doble ciego, placebo-controlado? → gold standard.
- Endpoint primario: ¿OS (ideal) o sustituto aceptado por FDA?
- ¿Hay Special Protocol Assessment (SPA) firmado con FDA? → PoS sube mucho.
- ¿Se hizo análisis interino con alpha spending correcto?

Historial FDA en la indicación específica:

SITUACIÓN	IMPLICACIÓN PoS
FDA aprobó exactamente este endpoint antes en esta indicación	+10–15pp PoS
FDA aprobó endpoint similar en indicación adyacente	+5pp PoS
Endpoint nuevo pero con precedente en otra área	Neutro
Endpoint completamente nuevo sin precedente	-10pp PoS
FDA rechazó este endpoint antes en esta indicación	-20pp PoS

AdCom histórico en la indicación:

- ¿Cuántos NDA/BLA fueron a AdCom en esta indicación en los últimos 5 años?
- Sin AdCom convocado → generalmente señal positiva.
- AdCom convocado tras CRL previo → señal de mayor escrutinio.
- ¿Hay conflictos de interés declarados en miembros del panel?

2.6 Probabilidad de aprobación (PoS) /3 ■ CRÍTICO

INDICACIÓN	Ph2→APROBACIÓN	MODIFICADORES PRINCIPALES
Oncología Ph2	~5–8%	BTD +10pp · CRL previo -15pp · SPA +15pp
Rare Disease Ph2	~15–25%	Orphan +7pp · Datos NEJM +10pp
CNS Ph2	~7–12%	Biomarcador validado +8pp · Diana maldita -15pp
Autoinmune Ph2	~10–15%	BTD +10pp · Competidor aprobado -5pp
Metabólico Ph2	~10–14%	CVOT requerido -10pp · OS endpoint +10pp
Otras Ph2	~10–15%	Fast Track +5pp · Endpoint nuevo -10pp

■ Designaciones FDA: Fast Track / Breakthrough / Orphan / RMAT → ajustar PoS al alza.

■ Historial de CRL o Clinical Hold previos → ajustar PoS a la baja.

SUBTOTAL PARTE 2 — Clínico y regulatorio

___/14

◆ PARTE 2.7 — PARTNERSHIPS Y COLABORACIONES /3 ■ NUEVO V3.1

Las asociaciones con farmacéuticas son una de las señales más potentes disponibles. Un deal grande valida la ciencia, elimina riesgo dilutivo y frecuentemente precede a M&A.;

A) Calidad y tamaño del partner /1

- ¿Es Big Pharma (Pfizer, Roche, Novartis, AZ, BMS) o mid-cap?
- ¿El partner tiene track record probado en esa indicación específica?

DEAL SIZE / MARKET CAP	SEÑAL
>100% market cap	■ Validación máxima — transformacional
50–100% market cap	■ Alta — deal significativo
20–50% market cap	■ Media — deal relevante
<20% market cap	■ Baja — deal táctico

B) Estructura del deal /1

- Upfront vs hitos: cuánto llega con certeza vs contingente.
- ¿Quién asume los costes de desarrollo? (50/50, 60/40, partner paga todo)
- ¿Hay opción de buy-in o adquisición preferente por el partner?
- ¿Royalties sobre ventas netas? (rango típico 10–20%)
- ¿Puede el partner terminar el acuerdo unilateralmente? → riesgo real.

C) Implicaciones estratégicas /1

- ¿El deal elimina riesgo dilutivo hasta el próximo catalizador?
- ¿Es señal de M&A; próxima? Histórico: 30–40% de deals grandes terminan en adquisición en 3 años.
- ¿El partner ha adquirido previamente a socios de colaboración?
- ■ NUEVO v3.1: ¿el partner actual tiene derecho de first refusal en adquisición?

SUBTOTAL PARTE 2.7 — Partnerships y colaboraciones

___/3

◆ PARTE 2.8 — VALOR DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA /3 ■ NUEVO V3.1 (GAP 2)

Solo aplicable a empresas Tipo C (Platform Technology). Para Tipo A y B se puntúa 0 automáticamente — no tienen plataforma.

A) Validación de la plataforma /1

NIVEL DE VALIDACIÓN	PUNTUACIÓN
Plataforma con ≥1 aprobación FDA/EMA	1/1 — validación máxima
Plataforma con datos Ph3 positivos publicados peer-reviewed	0.8/1
Plataforma con datos Ph2 positivos en ≥2 indicaciones distintas	0.6/1
Plataforma con datos Ph1 positivos en ≥2 indicaciones	0.4/1
Plataforma con solo datos preclínicos	0.1/1

B) Shots on goal independientes /1

Shots on goal = activos clínicos en indicaciones distintas donde un fracaso en uno no afecta a los demás. Activos en misma indicación con mismo mecanismo cuentan como 1.

SHOTS ON GOAL INDEPENDIENTES	PUNTUACIÓN
≥5 activos en indicaciones distintas	1/1
3-4 activos en indicaciones distintas	0.75/1
2 activos en indicaciones distintas	0.5/1
1 activo (single asset efectivo)	0/1

C) Ventaja competitiva de la plataforma /1

SITUACIÓN	PUNTUACIÓN
Plataforma genera activos imposibles de hacer de otra manera (first-in-class modal)	1/1
Plataforma genera activos mejores que el estándar con IP defendible (best-in-class modal)	0.7/1
Plataforma genera activos similares a competidores pero más rápido/barato	0.4/1
Plataforma no diferenciada vs moléculas individuales de competidores	0/1

SUBTOTAL PARTE 2.8 — Valor de plataforma tecnológica

 /3

◆ PARTE 3 — MANAGEMENT Y EQUIPO /4

3.1 Track record ejecutivo /2 ■ AMPLIADO v3.1

Track record básico:

- ¿CEO o CSO han aprobado fármacos antes? → señal más importante del equipo.
- Historial de dilución agresiva o gestión poco alineada con accionistas.

Insider transactions en contexto:

TIPO DE TRANSACCIÓN	SEÑAL	PESO
Compra abierta de mercado con cash propio	■ Máxima positiva	Alto
Ejercicio opciones + retención de acciones	■ Positiva	Medio
Ejercicio opciones + venta inmediata	■ Neutro	Ninguno
Venta planificada plan 10b5-1 pre-registrado	■ Neutro	Ninguno
Retención impuestos por vesting (withheld)	■ Neutro obligatorio	Ninguno
Venta abierta de mercado sin plan 10b5-1	■ Negativa	Alto
Múltiples C-suite vendiendo simultáneamente	■ Señal de alarma	Muy alto

■ NUEVO Gap 7 — Riesgo management turnover:

- ¿Hay cambios de C-suite en los últimos 6 meses? Si sí → investigar por qué.
- CEO que abandona <6 meses antes del PDUFA → señal de alarma grave.
- CSO que se va justo después de datos negativos → puede indicar conocimiento previo.
- Fundador que reduce stake al mínimo legal antes de catalizador → investigar siempre.
- Regla: verificar siempre plan 10b5-1 antes de interpretar ventas como negativas.

3.2 Calidad científica y KOL sentiment /2 ■ AMPLIADO v3.1

KOL sentiment externo:

TIPO PRESENTACIÓN CONGRESO	SEÑAL
Late-breaking oral en congreso tier-1 (ASCO, ASH, NEJM)	■ Máxima — seleccionado por relevancia
Oral en sesión principal	■ Alta
Oral en sesión temática	■ Media
Poster con presentación	■ Media-baja
Solo press release sin publicación peer-reviewed	■ Baja — datos no validados

- Publicado en NEJM/Lancet/JAMA → +10pp PoS, validación científica máxima.
- Editorial positivo de KOL no afiliado a la empresa → señal muy fuerte.
- Expanded Access activo → señal de demanda real antes de aprobación.
- Guías clínicas (NCCN, ESMO) que ya lo mencionan → adopción anticipada.
- Cartas al editor cuestionando datos o diseño → red flag a investigar.

SUBTOTAL PARTE 3 — Management y equipo

 /4

◆ PARTE 4 — RIESGO FINANCIERO Y DILUCIÓN /4 ■ CRÍTICO

4.1 Salud financiera y balance completo /2 ■ AMPLIADO v3.1 (Gap 6)

Métricas básicas:

- Caja actual + fecha del último 10-Q/20-F (siempre indicar la fecha).
- Burn rate mensual y runway en meses.
- ¿La caja cubre hasta el próximo catalizador clave? → pregunta más importante.
- Cash per share: suelo de valoración si todo va mal.

■ NUEVO Gap 6 — Balance completo más allá del runway:

- Deuda convertible: ¿importe? ¿% del market cap? ¿precio de conversión vs precio actual?
- Warrants outstanding: ¿% de shares? ¿precio de ejercicio? ¿overhang real?
- Royalty obligations: ¿hay revenue sharing con terceros sobre ventas futuras?

TIPO OBLIGACIÓN	IMPACTO
Sin deuda convertible ni warrants	■ Balance limpio
Convertibles <10% market cap, conversión >50% sobre precio actual	■ Bajo
Convertibles 10-30% market cap OR conversión cerca del precio actual	■ Medio
Convertibles >30% market cap OR conversión por debajo del precio actual	■ Alto
Class actions múltiples coordinadas con evidencia de irregularidad	■ Crítico

4.2 Riesgo de dilución /2 ■ AMPLIADO v3.1

Dilución histórica (3 años):

DILUCIÓN ACUMULADA 3 AÑOS	SEÑAL	ACCIÓN
<20%	■ Bajo — management alineado	Normal
20–50%	■ Moderado — normal en biotech	Verificar timing
>50%	■ Alto — management agresivo	Penalizar scoring
>100% (doblaron acciones)	■ Muy alto — destrucción sistemática	Reducir sizing

Calidad de la dilución:

- Para financiar Ph3 con datos positivos previos → aceptable.
- Para gastos operativos sin catalizador → señal negativa.
- Post-fracaso para sobrevivir → señal de desesperación.
- Fórmula: (coste Ph3 estimado - caja disponible) / precio actual = dilución máxima probable.

Regla práctica: runway <12 meses + catalizador >9 meses → riesgo alto de dilución.

SUBTOTAL PARTE 4 — Riesgo financiero y dilución

4

◆ PARTE 5 — IP Y PATENTES /2

- Fecha de expiración de patentes core del activo principal.
- Patent cliff: ¿cuándo entra competencia genérica/biosimilar?

- Litigios activos (IPR proceedings, Paragraph IV challenges).
- Extensiones posibles: pediatric exclusivity (+6m), NCE (5 años), Orphan (7 años).
- Freedom to operate: ¿hay riesgo de infringir patentes de terceros?

SUBTOTAL PARTE 5 — IP y patentes

___/2

◆ PARTE 6 — CATALIZADORES Y TIMELINE /4

CATALIZADOR	FECHA EST.	IMPACTO ESPERADO	PoS ÉXITO
Datos Ph2 / Ph3	___	___	___
Reunión FDA / AdCom	___	___	___
NDA / BLA filing	___	___	___
PDUFA date	___	___	___
Deal / Partnership anuncio	___	___	___

- Ventana óptima: catalizador en 3-9 meses → entrada con tiempo suficiente.
- ¿Hay opciones líquidas disponibles para gestionar el evento binario?
- ¿El partnership activo tiene milestones vinculados al catalizador próximo?

SUBTOTAL PARTE 6 — Catalizadores

___/4

◆ PARTE 7 — COMPETENCIA Y ACCESO AL MERCADO /4

7.1 Competencia granular /2 ■ AMPLIADO v3.1

Mapa competitivo por línea de tratamiento:

- ¿Misma indicación, misma línea, mismo endpoint? → competencia directa.
- ¿Misma indicación pero línea diferente? → mercado compartible.
- ¿Misma diana pero indicación diferente? → no es competencia real.

Tiempo de ventaja sobre el segundo competidor:

VENTAJA TEMPORAL	IMPLICACIÓN
>24 meses	Estándar de tratamiento consolidado antes de que llegue el competidor
12–24 meses	Ventaja real pero presión competitiva en el horizonte
6–12 meses	Carrera apretada — diferenciación en label es crítica
<6 meses	Lanzamiento simultáneo — el mercado lo tratará como commodity

- Effect size vs competidor: HR, ORR, reducción endpoint primario (%).
- Regla práctica: diferencial >20% en endpoint primario = ventaja defendible.
- Conveniencia: oral vs IV, frecuencia de dosis, refrigeración requerida.

7.2 Acceso al mercado global /2 ■ AMPLIADO v3.1 (Gap 4)

Riesgo EMA vs FDA:

- No asumir que FDA aprueba = EMA aprueba automáticamente.
- ¿EMA ya aprobó en indicación idéntica con mismo endpoint? → ■ precedente claro.
- ¿EMA nunca ha aprobado en esta indicación? → ■ proceso independiente completo.

■ NUEVO Gap 4 — Riesgo HTA por país:

PAÍS	ORGANISMO	CRITERIO MÁS EXIGENTE	RIESGO
Alemania	G-BA	'Zusatznutzen' — beneficio adicional vs SOC. Si 'no benefit' → precio genérico	■ Alto
UK	NICE	QALY threshold £20-30K. Si coste/QALY >£30K → no recomendado	■ Alto
Francia	HAS	ASMR I-V. Si ASMR IV-V → precio muy comprimido	■ Medio
Japón	PMDA	Puede requerir ensayos locales o bridging study	■ Medio

Dependencia geográfica:

- <20% revenue fuera de US → riesgo internacional menor.
- 20-40% fuera de US → HTA relevante pero no crítico.
- >40% fuera de US → HTA puede destruir la tesis comercial.

7.3 Ejecución comercial post-aprobación /3 ■ NUEVO v3.1 (Gap 5)

Solo aplica a Tipo C con producto aprobado y Tipo D. Para Tipo A y B se puntúa 1/1 automáticamente — prematuro evaluarlo.

A) Velocidad de adopción esperada /1

FACTOR	ADOPCIÓN RÁPIDA	ADOPCIÓN LENTA
Vía administración	Oral diario	IV mensual / implante
Test diagnóstico requerido	No	Sí (companion dx)
Especialista prescriptor	Médico general / internista	Subespecialista raro
Prevalencia indicación	>100K pacientes US	<10K pacientes US
Alternativas disponibles	Pocas o ninguna	Múltiples establecidas
Experiencia equipo comercial	Equipo veterano indicación	Primer lanzamiento

Puntuación: ≥ 4 factores rápidos $\rightarrow 1/1$ · 2-3 factores $\rightarrow 0.5/1$ · ≤ 1 factor $\rightarrow 0/1$

B) Landscape de payers y prior authorization /1

SITUACIÓN	PUNTUACIÓN
CMS/Medicare cubre sin prior authorization + privados idem	1/1
Cobertura con prior authorization manejable (<30 días)	0.7/1
Prior authorization compleja + step therapy requerida	0.4/1
ICER assessment negativo publicado	0/1

C) Calidad del equipo comercial /1

SITUACIÓN	PUNTUACIÓN
Equipo veterano con experiencia en indicación + >200 reps globales	1/1
Equipo nuevo pero con hires de competidores experimentados	0.7/1
Equipo pequeño (<100 reps) con indicación de alta especialización	0.5/1
Primer producto comercial, sin experiencia de lanzamiento	0.3/1
Depende de partner para comercialización	0.2/1 — riesgo de ejecución externa

SUBTOTAL PARTE 7 — Competencia y mercado

 /4

◆ PARTE 8 — ESTRUCTURA BURSÁTIL /2 ■ AMPLIADO V3.1 (GAP 8)

MÉTRICA	VALOR	FUENTE
Market Cap	—	Yahoo Finance / Bloomberg
Enterprise Value (EV)	—	EV = Cap + Deuda - Caja
Caja neta	—	Último 10-Q
Acciones (basic / diluted)	—	10-Q / 10-K
Institutional ownership	—	13F filings
Insider ownership	—	Proxy statement
Short interest % float	—	FINRA / Ortex
Cash per share	—	Floor de valoración

■ NUEVO Gap 8 — Calidad de la base accionarial:

- ¿Un solo hedge fund tiene >15% del float? → riesgo de salida masiva.
- ¿Top 3 holders tienen >50% del float? → cualquier salida mueve el precio violentamente.
- ¿Hay crossover investors (fondos pre-IPO que siguen en público)? → señal de calidad.
- Short interest institucional coordinado (>5 fondos simultáneos) → más significativo que retail.
- Short interest alto (>20% float) → investigar si es squeeze o riesgo real.

SUBTOTAL PARTE 8 — Estructura bursátil

12

◆ PARTE 9 — VALORACIÓN RNPV INSTITUCIONAL /4 ■ CRÍTICO

9.1 Inputs por activo

- Indicación + línea de tratamiento + población elegible.
- Peak Sales — validar con 3 métodos: top-down, bottom-up, comparable.
- Años hasta lanzamiento desde fase actual.
- Tasa de descuento: 10% plataforma / 15% single asset.
- PoS acumulada desde fase actual (tasas BIO/IQVIA, no inventadas).
- ■ NUEVO v3.1: incluir milestones de partnerships y royalties VEPPANU-style como flujos adicionales.

9.2 Fórmula rNPV

rNPV (por activo) = Peak Sales × margen neto × múltiplo revenue × PoS acumulada / (1 + r)^t

rNPV empresa = Σ rNPV activos + caja neta + milestones partnership (ajustados PoS) + royalties pasivos – deuda

9.3 Escenarios

ESCENARIO	PoS AJUSTADA	rNPV / ACCIÓN	UPSIDE VS PRECIO
Pesimista	—	—	—
Base	—	—	—
Optimista	—	—	—
Éxito total	—	—	—

9.4 Benchmarks y M&A;

- EV/rNPV ratio vs peers cotizados. ¿Cotiza con descuento >40%? → señal de valor.
- Transacciones M&A; comparables: precio pagado por activo similar.
- Probabilidad de buyout × premium histórico del sector (~50-70% en oncología).
- ■ NUEVO v3.1: ¿el partner actual tiene derecho de first refusal en adquisición?

9.5 Criterios de valoración atractiva

- rNPV/acción escenario base > 2x precio actual → margen de seguridad mínimo.
- EV/rNPV < 0.5 → cotiza con descuento significativo al valor intrínseco.

9.6 Ratio asimetría de entrada /2 ■ NUEVO v3.1 (Gap 1)

Captura oportunidades donde el precio de entrada está tan cerca del floor que el downside es mínimo respecto al upside potencial.

SITUACIÓN	PUNTUACIÓN
Precio < caja neta/acc (EV negativo)	2/2 — asimetría máxima · downside teórico ~0%
Precio entre 1x y 1.5x caja/acc	1.5/2 — asimetría alta
Precio entre 1.5x y 2x caja/acc	1/2 — asimetría moderada
Precio entre 2x y 3x caja/acc	0.5/2 — asimetría baja
Precio >3x caja/acc	0/2 — sin protección de floor

- Bonus +0.5: upside en escenario optimista >5x el downside máximo.
- Bonus +0.5: ≥3 activos independientes que pueden mover el precio sin correlación.

SUBTOTAL PARTE 9 — Valoración rNPV + Asimetría

___/4

◆ PARTE 10 — ESCENARIO DE FRACASO CON GRANULARIDAD ■ AMPLIADO V3.1

TIPO DE FRACASO	IMPACTO PRECIO	RECUPERA BLE	IMPLICACIÓN
Toxicidad grave (muertes relacionadas)	-70 a -90%	No	Mata activo y daña plataforma
Fallo eficacia en población total	-50 a -70%	Parcialmente	Posible refinamiento biomarcador
Fallo primario, señal en secundario	-30 a -50%	Sí	Base para rediseño del ensayo
CRL por problemas CMC/manufactura	-20 a -40%	Sí (6-18m)	No mata la ciencia
CRL por datos insuficientes (no safety)	-30 a -50%	Sí	Necesita más datos
Fallo subgrupo, éxito población amplia	-10 a -20%	Sí	Label más estrecho

Valor residual post-fracaso — granular:

- Caja neta disponible inmediatamente.
- Valor activos secundarios no afectados por el fracaso.
- Valor de la plataforma tecnológica si es transferible o licenciable.
- ■ NUEVO v3.1: ¿el partnership actual sobrevive al fracaso del activo principal?
- ■ NUEVO v3.1: ¿los royalties pasivos (VEPPANU-style) siguen generando revenue independientemente?

Si floor de valoración (caja neta/acción) está cerca del precio actual → riesgo asimétrico favorable.

◆ PARTE 11 — CHECKLIST PONDERADO V3.1

Puntuar cada criterio: 2 = cumple plenamente / 1 = cumple parcialmente / 0 = no cumple o riesgo alto

CRITERIO	PESO	PUNT.
1. Eficacia clínicamente relevante (effect size, no solo p-value)	Alto	—
2. Datos consistentes, sin cambios de endpoint	Alto	—
3. Endpoint aprobable FDA/EMA — acordado en SPA y validado vs historial FDA	Alto	—
4. Seguridad aceptable vs estándar actual	Alto	—
5. Ensayo randomizado, doble ciego, bien diseñado	Medio	—
6. PoS desde fase actual >60%	Alto	—
7. Sin dilución inminente (runway >12m) + dilución histórica <20% + balance limpio	Alto	—
8. Catalizador en ventana 3-9 meses	Medio	—
9. Mercado grande + acceso al reembolso viable + HTA favorable	Medio	—
10. rNPV/acción escenario base >2x precio actual	Alto	—
11. EV/rNPV <0.5 + asimetría de entrada favorable	Medio	—
12. Management con track record probado + insiders alineados + sin turnover reciente	Alto	—
13. IP sólida: patente principal >7 años o protección regulatoria suficiente	Medio	—
14. Floor de valoración (caja/acción) razonable si falla	Alto	—

■ 15. Partnership con Big Pharma validador + estructura favorable	Alto	—
■ 16. KOL sentiment positivo + publicación peer-reviewed top tier	Medio	—
■ 17. Plataforma tecnológica validada con shots on goal independientes (Tipo C)	Alto	—
■ 18. Ejecución comercial viable: adopción + payers + equipo (Tipo C/D)	Medio	—

◆ PARTE 12 — SCORING FINAL PONDERADO V3.1

PARTE	PESO v3.1	PUNTOS	NORMALIZADO
2. Clínico y regulatorio	20%	___/14	___
2.7 Partnerships y colaboraciones	11%	___/3	___
2.8 Valor de plataforma (NUEVO Gap 2)	7%	___/3	___
3. Management + KOL sentiment	7%	___/4	___
4. Riesgo financiero / dilución + balance	16%	___/4	___
6. Catalizadores	10%	___/4	___
7. Competencia / mercado / ejecución comercial	6%	___/4	___
8. Estructura bursátil + ownership	4%	___/2	___
9. Valoración rNPV + asimetría entrada (Gap 1)	19%	___/4	___
TOTAL PONDERADO (0–20)	100%	—	___

SCORE	LECTURA	ACCIÓN	SIZING
18–20	Excelente	■ COMPRAR	Posición core (5-8% cartera)
15–17	Buena candidata	■ COMPRAR	Posición normal (3-5%)
12–14	Interesante con riesgos	■ VIGILAR	Posición pequeña (1-2%)
9–11	Especulativa	■ VIGILAR	Solo si catalizador inmediato (<1%)
<9	Descartar	■ DESCARTAR	No entrar

◆ PARTE 13 — GESTIÓN DE POSICIÓN

Niveles de entrada

- Precio actual vs rNPV escenario pesimista (suelo fundamental).
- ¿Hay soporte técnico relevante que confirme la entrada?
- ■ NUEVO v3.1: ¿hay milestone de partnership próximo que actúe de catalizador?

■ NUEVO Gap 3 — Modificador por ciclo sectorial

SCORE FUNDAMENTAL	CICLO EN FONDO	CICLO NEUTRAL	CICLO EN TECHO
COMPRAR (≥16)	Sizing ×1.5 (hasta 7-8%)	Sizing ×1.0 (3-5%)	Sizing ×0.7 (2-3%)
COMPRAR (15-17)	Sizing ×1.5 (hasta 5-6%)	Sizing ×1.0 (3-5%)	Sizing ×0.7 (1-2%)
VIGILAR (12-14)	Sizing ×1.5 (hasta 2-3%)	Sizing ×1.0 (1-2%)	Sizing ×0 — no entrar
VIGILAR (9-11)	Sizing ×1.0 (1%)	Sizing ×0	Sizing ×0

Indicadores de ciclo en fondo: subsector >40% desde máximos + sentiment negativo + offerings a descuento + analistas bajando PTs + 13F mostrando reducción de posiciones.

Triggers de SALIDA — definir antes de entrar

TRIGGER	ACCIÓN
Fracaso endpoint primario	Salida inmediata
Fracaso por toxicidad (muertes)	Salida inmediata — no esperar
Dilución >20% inesperada	Revisar tesis, reducir posición
Retraso >6 meses en catalizador	Reducir posición, esperar claridad
Partner termina colaboración unilateralmente	Revisar tesis urgente
Aprobación (PDUFA positivo)	Evaluar BTRSSTN — sell the news
Deal M&A; anunciado	Mantener hasta cierre si premium >50%
KOL sentiment negativo masivo post-congreso	Revisar PoS y sizing
CEO/CSO abandona <6 meses antes de catalizador	Investigar antes de mantener
Holder >15% anuncia reducción de posición	Vigilar impacto en precio — no vender automáticamente

◆ PARTE 14 — CONCLUSIÓN FINAL

PREGUNTA	RESPUESTA
1. Encaje en modelo principal	___
2. Encaje en modelo biotech mini	___
3. Probabilidad de aprobación (%)	___
4. Riesgo de dilución	Alto / Medio / Bajo
5. Partnership activo y su impacto	___
6. KOL sentiment	Positivo / Neutro / Negativo
7. Riesgo regulatorio internacional	Alto / Medio / Bajo
8. Riesgo ejecución comercial	Alto / Medio / Bajo · N/A si pre-comercial
9. Riesgo balance (convertibles, litigios)	Alto / Medio / Bajo
10. Ciclo sectorial	Fondo / Neutral / Techo → modificador sizing
11. Ventana de entrada óptima	___
12. Ventana de salida recomendada	___
13. Potencial 12-24 meses (% upside base)	___
14. Riesgo-beneficio (0-10)	___
15. Comparación con cartera actual	___

MODELO BIOTECH v3.1

■ **COMPRAR / VIGILAR /
DESCARTAR**

___ / **20**

■■ No es consejo de inversión. Framework diseñado para análisis personal de inversión en biotech. Invertir en biotech implica riesgo elevado de pérdida total del capital. Consultar con asesor financiero autorizado antes de tomar decisiones de inversión.

Fuentes válidas: FDA · EMA · ClinicalTrials.gov · SEC/EDGAR · IR oficial · Papers peer-reviewed.